

基药目录首纳创新药系列研究

覆盖≠放量

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-10

摘要

基药目录首次批量纳入创新药，叠加"986"配备要求，被市场视为高价创新药院内放量的重大催化。但本报告认为，政策红利在传导链条中存在显著衰减。986考核的是品种数量而非实际采购量，医院可通过"形式配置"满足考核，而不必改变临床用药行为。创新药从"入院"到"放量"之间横亘着临床路径、DRG/DIP控费、科室预算、患者支付能力等多重约束，医生的处方权不受行政命令统一。对于覆盖率尚低的品种，基药目录是打开医院大门的钥匙，销售峰值上修弹性较大；但对于覆盖已广的品种，瓶颈已从院端准入转向单院产出，政策边际帮助迅速下降。单院产出不是从入院起点开始的光滑曲线，而是必须等真实采购资格、科室路径纳入、患者支付闭环三张通行证全部就位后的二次启动变量。覆盖医院数与收入增速的剪刀差，是判断瓶颈是否后移的最直接信号。

CHAPTER 01

基药与986打开医院大门，但处方权留在医生手里

■ 986数的是品种，不是销量

2019年10月，一份文件下达到基层医院：基本药物配备品种数量占比，基层90%、二级80%、三级60%。2020年，“1+X”用药模式跟进，“1”是基药目录，“X”是非基药。至此，医院药品配备的硬框架成型。

这个框架的初衷，是让基本药物主导临床。但创新药的处境，比这个框架复杂。2026年7月，新版基药目录从685种扩容到794种，首次批量引入16种创新药——荣昌的泰它西普、康诺亚的司普奇拜单抗、先声的依达拉奉右莰醇。这些药在进基药之前，大多已经进了医保。它们走的是“先医保、后基药”的路径。

986考核的是品种数量，不是采购金额，更不是使用量。医院只要在目录里列出创新药的名字，就算完成配备。一瓶药进了药房，和这瓶药被患者买走，之间隔着一条鸿沟。药剂科最理性的做法，是在系统中“挂名”这些创新药，以满足考核，但在实际采购中，考虑到价格、科室需求、库存周转，未必进行大规模采购。

这种“形式配置”在三级医院尤为突出。三级医院药品目录庞大，临床需求复杂。要在数千品规中确保60%是基药，同时满足各科室对高端专科药的需求，药剂科的策略是：目录层面多纳入基药，稀释非基药占比，但在采购和供应上，优先保障使用量大、科室呼声高的传统品种。创新药进了目录，但可能因为单价高、使用人群窄、医生不熟悉，在采购端被边缘化。

更微妙的是，2021年10月，国家已废止医疗机构基本用药供应目录品规数作为评审指标。2025年至2026年的政策也明确，不得以用药目录数量、药占比限制创新药。理论上，药品零加成和DRG/DIP已让医院形成费用自控动力，不再需要硬性数量限制。但实际操作中，986考核压力依然存在，医院仍倾向用“凑数”方式达标，而非真正改变临床用药行为。一个学生为完成课外阅读，在书单上勾选所有名著，真正翻开读过的寥寥无几。

■ 药房有药，不等于医生开药

药品进了医院采购目录，只是万里长征第一步。从药房到患者体内，中间隔着临床科室的处方权。在中国公立医院，医生开什么药，不是个人选择，而是受多重因素制约。

首先是临床路径。疾病一旦被纳入临床路径管理，医生的用药选择就被大幅压缩。创新药如果没有被纳入相关疾病的临床路径，即使药房有库存，医生也很难在常规诊疗中开具。推动创新药进入临床路径，需要大量循证医学证据、专家共识、指南更新，远比纳入基药目录困难。

其次是DRG/DIP的刚性约束。医保按病种给医院固定支付标准，无论治疗过程用了什么药，医保支付的钱固定。如果用了高价创新药，总费用超出打包标准，超出部分医院自己承担。这相当于给医院套上了紧箍咒。2025年政策提出，合理使用医保目录内创新药可申报特例单议，但"特例"意味着额外审批和论证材料。繁忙的临床工作中，医生不愿为此耗费精力。特例能否通过、多久批下来，都不确定。

在这种支付制度下，医院的经济理性是优先使用性价比高的传统药物。一位三甲医院外科医生描述自己的困境："我知道某个创新药效果更好，但用了这个药，治疗费用就超出DRG标准，科室亏钱。年底考核，科室绩效受影响，我的奖金也受影响。你说我怎么办？"

科室预算也是现实约束。科室运营成本需要自负盈亏，药品费用是重要组成部分。大量使用高价创新药，即使进了医保，也可能导致药品支出占收入比例过高，影响绩效评价。科室主任制定内部用药规范时，往往倾向控制高价药使用，或设置门槛——只有达到一定严重程度病人才能使用。这形成一道无形门槛，把许多潜在使用者挡在门外。

患者支付能力是最后一道、最现实的过滤器。即使进了医保，患者仍需支付一定比例的自付费用。年治疗费用数万元的创新药，自付部分对普通家庭仍是沉重负担。门诊场景中，患者看到处方价格可能直接拒绝；住院场景中，医生需要与家属艰难沟通，解释疗效与费用权衡。如果家属最终选择放弃，医生就不会开处方。这"最后一公里"的支付障碍，政策文件无法直接干预，取决于居民收入、医保报销比例、大病保险和医疗救助覆盖，以及患者对疾病和治疗的认知。

■ 医生的笔，不听行政命令

把这些约束放在一起，就能理解为什么纳入基药目录对创新药销售的拉动，主要在"入院"环节，而非"处方"环节。

从医院管理层看，迎接创新药入院是"政治任务"和"考核任务"。基药目录更新，医院需要在规定时间内召开药事会。多地政策要求医保目录发布后3个月内召开药事会，部分地区要求1个月。上海、浙江、江苏还建立常态化公示机制，每季度公开国谈药院内配备情况。这些外部压力推动医院在形式上完成创新药准入。

但药事会通过之后，药品进入的是药房，不是医生的处方笺。从药房到处方，中间横亘着临床科室的自主权。在中国，科室主任对本科室用药行为拥有实质性决定权。主任可以制定科室内部用药规范，要求下级医生开具高价药前获得上级同意，在科室会议上讨论决定哪些新药值得推广、哪些暂时观望。这种科层制决策结构，使医院层面的政策很难穿透到临床一线。

医生的处方行为是高度专业化的决策，涉及对患者病情的判断、药物疗效和安全性的评估、既往治疗经验的依赖，以及医患关系的维护。这种决策不可能通过行政命令统一。即使卫健委发文要求优先使用创新药，即使医保局强调不得以药占比限制创新药，医生面对具体病人时，仍会根据多年临床经验和当下情境做出判断。如果医生对创新药疗效不够了解，或对副作用有顾虑，或担心使用后引发医患纠纷，就会本能选择更熟悉的传统药物。

学术推广是药企影响医生处方的主要手段，但效果层层衰减。医学代表可以介绍临床试验数据，邀请医生参加学术会议，提供样本试用。但医生是否接受信息、是否愿意改变处方习惯，取决于多种因素：对代表的信任程度、本人的学术偏好和开放程度、科室内部舆论氛围、医院对药企活动的管理规定。在带量采购和医药反腐背景下，医院对药企推广活动的管控日益严格，学术推广的渠道和效果都在收缩。

从基药目录纳入到实际处方量提升，中间存在巨大的传导损耗。医院准入转化率可能很高——因为医院有动力和能力完成这项任务——但科室处方采纳率的提升则要缓慢得多、困难得多。一条水管，源头水压很大，但中间有很多漏点和狭窄弯道，最终从水龙头流出的水量，远低于源头的供给。

CHAPTER 02

目录事件不是终点，漏斗瓶颈才是

■ 覆盖率低的品种，目录是钥匙

要理解创新药销售峰值如何被重估，先建立一个“漏斗”模型。漏斗从上到下：终端覆盖（多少医院理论上可以采购）、院端准入（多少医院实际纳入采购目录）、稳定产出（多少医院持续采购并产生稳定销售）、院内可用（多少医生愿意开具处方并真正用于患者）。基药目录和986政策，主要作用在漏斗第二层——院端准入，能推动更多医院把创新药纳入采购目录，但对第三层和第四层的影响力明显衰减。

对于不同发展阶段的创新药品种，基药目录纳入带来的销售峰值上修弹性截然不同。如果一款创新药目前只进入少数医院，基药目录纳入就像一把钥匙，能够打开大量此前紧闭的大门。以康诺亚的司普奇拜单抗为例，这款用于治疗特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉的生物制剂，2025年底医保谈判后，截至2026年1月20日进入185家医院，到3月底快速扩展至1500家以上。对于刚进入商业化阶段的产品，从185家到1500家，覆盖率提升数倍，直接带来销售收入跨越式增长。2024年销售额约4000万元，2025年达到3.15亿元，2026年市场预期可能达到7.5亿元。这种爆发式增长，主要驱动力就是医院覆盖面的快速扩张。

在这种情况下，基药目录纳入相当于给医院准入提供"政策背书"。医院药剂科考虑引进新药时，面临诸多不确定性：这个药会不会很快被淘汰？医保报销会不会出问题？临床需求到底有多大？基药目录身份在一定程度上消除这些顾虑，因为纳入基药目录意味着国家层面认可了药品的临床价值、安全性和成本效益。尤其对原本持保守态度的二级医院和基层医院，基药目录纳入可能是决定性推动因素。

从数学关系看，当覆盖率处于较低水平时，覆盖医院数增加与销售收入增加之间近似线性关系。假设一家医院平均每年贡献50万元销售额，从100家扩展到1000家，理论上意味着从5000万增加到5个亿。这种增量容易计算，也可预期。投资者看到覆盖率快速爬坡，会自然调高销售峰值预期，因为"覆盖更多医院=更多销售"这个逻辑简单直接，容易被市场接受和定价。

■ 覆盖广的品种，瓶颈在单院

但当一款创新药已覆盖相当数量医院，基药目录纳入带来的边际增量迅速递减。此时，漏斗瓶颈从"院端准入"转移到"单院产出"——每家医院能产生多少销售额。先声药业的先必新（依达拉奉右莛醇注射用浓溶液）是典型例子。这款用于治疗急性缺血性脑卒中的创新药，截至2025年底覆盖超过6500家医疗机构，在卒中注射液市场份额约31%。对于已覆盖如此广泛的品种，基药目录纳入带来的新增医院数量有限——大多数可能有需求的医院已经引进了这款药。此时，销售增长主要驱动力不再是"进多少家医院"，而是"每家医院用多少"。

单院产出提升取决于多个因素：医生对产品的认知度和认可度、产品在临床路径中的地位、与竞品的差异化优势、患者支付能力、科室内部推广力度。这些因素与基药目录或986政策关系已不大。即使政策要求医院配备基药，如果医生在临床上没有足够的动力使用，单院产出就不会有明显提升。政策可以推动药品"进院"，但很难推动药品"进医嘱"。

荣昌生物的泰它西普也处于类似阶段。截至2025年底，泰它西普准入超过1200家医院，维迪西妥单抗超过1050家。对于已覆盖核心医疗网络的品种，2026年基药目录纳入固然是利好，但带来的增量主要是此前尚未覆盖的二级医院和基层医院。这些医院在自身免疫性疾病和肿瘤治疗方面的患者流量和专业能力相对有限，即使引进药品，产生的单院产出也远低于三甲医院。基药目录纳入对销售峰值的提升，更多体现为“长尾市场”的渐进式开发，而非爆发式增长。

这时候，投资者需要调整估值模型中的关键变量。对于覆盖已广的品种，峰值销售的上修弹性不再取决于“医院数量增速”，而是取决于“单院产出增速”，而后者又取决于处方渗透率、人均治疗时长、适应症拓展等更复杂因素。简单把基药目录纳入等同于销售峰值大幅上修，就会犯“线性外推”的错误。

■ 单院产出，是峰值公式的乘数

创新药销售峰值测算中，有一个经典公式：峰值销售 = 覆盖医院数 × 单院平均产出。这个公式看似简单，但背后经济学含义丰富。当漏斗瓶颈处于“院端准入”环节时，覆盖医院数是驱动增长的核心变量；当瓶颈转移到“科室处方采纳”环节时，单院平均产出变成核心变量。基药目录和986政策主要影响前者，对后者影响间接且有限。

单院产出又可进一步分解：处方医生数 × 人均处方量 × 患者人均治疗费用。每个子变量都受临床现实严格约束。处方医生数增长取决于医学推广效率和医生教育深度，这不是一朝一夕能完成的。人均处方量增长取决于患者治疗依从性、产品疗效口碑、替代治疗方案竞争。患者人均治疗费用取决于药品定价、医保报销比例、患者自付能力，以及治疗持续时间。

以康诺亚的司普奇拜单抗为例，分析师预测其销售峰值时，假设特应性皮炎适应症渗透率可达4.5%，对应约9万患者人群。但这只是理论上的患者天花板。真正决定销售额的，是这些患者中有多少能够持续用药。根据治疗指南，中重度特应性皮炎维持治疗需持续六个月以上，如果患者达到EASI90，还可考虑延长治疗并适当减量。但现实中，患者实际治疗持续时间（DOT）往往低于指南推荐。康诺亚目前DOT约8到9针，竞品杜普利尤单抗可做到近六个月。如果DOT不能有效延长，即使患者基数很大，峰值销售也会受到明显限制。

荣昌生物的泰它西普情况更复杂。泰它西普已获批多个适应症：系统性红斑狼疮、重症肌无力、干燥综合征、IgA肾病等。每个适应症临床路径不同、患者人群不同、治疗方案不同，单院产出构成也就不同。在以风湿免疫科为主的医院，主要使用场景是系统性红斑狼疮和干燥综合征；在以肾内科为主的医院，主要场景是IgA肾病。不同科室的处方习惯、患者流量、治疗周期都有差异，单院产出预测变

得极为复杂。基药目录纳入可以推动医院引进药品，但无法改变不同科室的临床行为差异。

■ 横向覆盖看准入，纵向深度看处方

医院准入解决"横向覆盖"问题——创新药能触达多少家医疗机构；科室处方采纳解决"纵向深度"问题——创新药在每家医疗机构内部能渗透到多深的临床场景。基药目录和986政策对横向覆盖的推动比较直接，但对纵向深度的推动需要经过多重传导，且衰减严重。

横向覆盖的扩张有天花板。中国公立医院总数有限，对某些治疗领域的创新药，真正有患者流量和治疗能力的医院可能只有几百家到一千多家。一旦覆盖这些核心医院，再向下级医院扩展的边际价值递减。基层医院数量庞大，但专科疾病诊疗能力、患者流量、支付能力与三级医院存在显著差距。用于治疗罕见病或复杂慢病的创新药，即使进入所有基层医院，产生的销售额可能还不及几家顶级三甲医院。

纵向深度的提升几乎没有天花板。如果一家医院有100位可以处方某创新药的医生，目前只有10位在开这个药，把处方医生数从10位提升到50位，单院产出就能提升数倍。如果再让每位处方医生的平均处方量翻倍，单院产出又能再翻倍。这种纵向深度提升虽然困难，但一旦实现，对销售峰值的贡献持续且巨大。

评估基药目录纳入对创新药销售峰值的影响，关键是判断品种漏斗瓶颈目前处于哪个环节。对于刚获批、刚进入医保、覆盖率尚低的品种，基药目录纳入意味着横向覆盖加速扩张，销售峰值上修弹性很大。对于已覆盖主要医院网络、渗透率较高的品种，基药目录纳入边际效应有限，真正增量要看纵向深度能否打开。而后者取决于临床路径纳入、医生教育成效、支付政策配套、患者管理优化，都不是目录事件本身能直接解决的。

CHAPTER 03

同一批入院，三条放量梯队

■ 药事会不是开关，路径评审不是流水线

即使基药目录纳入顺利推动创新药进入医院采购目录，入院之后的上量过程也远非平滑线性。现实中，药品从"准入"到"放量"之间隔着多个环节，每个环节效率和节奏差异巨大。这些差异导致同一批准入的医院，被自然分层为不同放量梯队。

第一个环节是药事会。政策要求医院在规定时间内召开药事会，审议新纳入药品配备事宜。但“应当”不等于“立即”，更不保证所有医院能在规定时限内完成。现实中，医院召开药事会频率差异很大。管理规范的大型三甲医院每季度甚至每月召开一次，新目录发布后不久就能完成审议；有些医院一年只召开一两次，新药准入可能要等半年甚至一年。还有些医院虽然召开了药事会，但议程排满，创新药审议被排在后面，或因专家意见分歧未能通过。

更重要的是，药事会通过只是形式准入。药品进入药房后，还需要经过临床科室试用和评估。这个阶段节奏更不可控。有些科主任对新药持开放态度，愿意在合适患者身上试用；有些主任更保守，要求看到更多本院实际使用数据后才扩大使用范围。有些科室内部有明确的新药试用流程，从申请到批准只需几天；有些科室需要层层审批，耗时数月。这些差异使同一批在2026年基药目录中获批的创新药，在不同医院实际落地时间可能相差半年以上。

临床路径评审效率是另一个关键变量。如果创新药能被纳入某种疾病的临床路径，它的使用就会从“个别医生选择”变成“科室常规做法”，放量速度显著加快。但纳入临床路径需要严格循证评价和专家论证，过程比药事会审议漫长得多。有些医院积极参与全国性指南和路径制定，能较快跟进最新治疗规范；有些医院习惯沿用旧版路径，更新速度滞后。这种路径评审效率差异，进一步加剧不同医院上量节奏分化。

■ 同一批入院，三种命运

由于环节切割，同一批准入医院分化成三个明显梯队。

第一梯队是“快速放量型”。这些医院通常具备：药事会召开频繁、决策效率高；相关科主任对创新药认可度高，有参与临床试验或早期使用经验；科室内部有完善的新药引入和试用机制；所在地区医保支付政策相对宽松，对创新药使用限制较少；患者群体支付能力较强。在这些医院，创新药可能在准入后第一个季度就开始产生显著销售，随后几个季度持续快速爬坡。以康诺亚司普奇单抗为例，北京同仁医院、上海华山医院、武汉同济医院等皮肤科头部三甲医院，就是典型快速放量型医院。这些医院不仅患者流量大，在专科领域有全国影响力，医生处方行为往往被下级医院医生效仿，具有“灯塔效应”。

第二梯队是“零星处方型”。这些医院也完成创新药准入，但上量过程缓慢而不稳定。可能只有一两名医生在尝试使用，处方量时有时无，取决于个别患者病情和支付能力。科主任对新药持观望态度，或科室预算紧张控制使用，或DRG/DIP支付压力不敢放开。在这些医院，创新药销售长期维持较低水平，偶尔小幅波动，缺乏持续增长动能。只有外部条件变化——科主任换届、临床路径更新、医

保支付政策调整、或出现强有力的真实世界证据——才可能打破僵局，推动上量进入加速通道。

第三梯队是“基本未放量型”。这些医院形式上完成创新药准入，药品在药房系统中有库存，但几乎没有产生销售。原因多方面：相关科室临床重点与创新药适应症不匹配，比如以肿瘤治疗为主的医院引进自免领域创新药，相关科室患者稀少；医生对创新药了解不足，缺乏使用信心；医院内部行政壁垒导致药品虽进药房，科室无法便捷获取；或医院本身患者流量有限，即使医生愿意使用，也找不到足够患者。这些医院在统计数据上被计入“覆盖医院数”，但对实际销售贡献微乎其微，相当于“僵尸准入”。

这种分层不是静态的。随着时间推移和外部条件变化，医院可能在不同梯队之间迁移。原本零星处方型的医院，如果科室主任参加学术会议后对新药产生兴趣，或医院收到上级要求加强创新药使用的通知，可能快速转入快速放量型。反之，原本快速放量的医院，如果DRG/DIP支付改革导致科室亏损，或出现严重药品不良反应事件，也可能退回到零星处方甚至基本未放量状态。

■ 覆盖数与收入增速的剪刀差，是最诚实的预警

由于环节切割和医院分层，覆盖医院数与销售收入增速之间往往出现“剪刀差”——覆盖医院数持续增长，但收入增速没有同步提升，甚至开始放缓。这个剪刀差是判断漏斗瓶颈是否后移的最重要信号。

创新药商业化早期，覆盖医院数和收入增速通常同步快速上升。每新增一家医院，意味着一个新的销售来源，收入增速与覆盖增速基本匹配。这个阶段，市场关注焦点是“进了多少家医院”，因为这是最容易量化、最直观的指标。

但随时间推移，新增医院边际产出递减。后期增量医院大多是下级医院或基层医院，单院产出远低于早期覆盖的核心三甲医院。同时，早期覆盖医院中，有一部分可能已进入增长平台期，单院产出不再提升。这时，即使覆盖医院数仍在增加，收入增速也会放缓。如果覆盖增速与收入增速之间的gap持续扩大，说明瓶颈已从“准入”环节后移到“处方”环节，“横向覆盖”的增量无法弥补“纵向深度”的不足。

以先声药业先必新为例。这款药已覆盖6500多家医疗机构，覆盖率不可谓不高。但未来收入增长主要依赖什么？显然不是再进更多医院，而是提升现有医院单院产出，或拓展新适应症、新使用场景。如果观察到先必新收入增速开始明显低于覆盖医院数增速，或单院平均产出下滑，意味着这款药在现有医院网络中的处方渗透率已趋于饱和，需要新增长点驱动下一阶段发展。

对于荣昌生物泰它西普和维迪西妥单抗，同样存在问题。截至2025年底，泰它西普准入1200家医院，维迪西妥单抗1050家。这些数字看起来已相当可观。但2026

年收入增速能否维持2025年水平，关键不在于能否再进几百家医院，而在于现有1200家或1050家医院中，每家医院使用量能否继续提升。如果覆盖医院数继续增加，但收入增速放缓，剪刀差扩大，那就明确警示：瓶颈已后移到处方采纳和单院产出环节，再想靠基药目录或986政策推动增长，效果将非常有限。

覆盖医院数与收入增速的剪刀差，也可用来识别哪些品种真正由“准入驱动”，哪些已转向“处方驱动”。对于前者，基药目录纳入边际效用较高；对于后者，投资者需要把分析重点从“医院覆盖”转向“单院产出”，从“政策事件”转向“临床行为”。这种视角转换，对准确评估创新药销售峰值至关重要。一个药品的价值，最终不是由它进了多少家医院药房决定的，而是由多少患者真正使用了它、并从中获益决定的。

CHAPTER 04

单院产出不是一条光滑曲线，而是台阶与S型的混合

■ 五层漏斗，堵在哪层，曲线就长什么样

把创新药在一家医院内部从“名义上存在”到“真正被患者持续使用”拆解，可看到五个层次的传导漏斗。第一层是目录准入与挂网采购。药品进入医保或基药目录，只是获得进入医院采购清单的“法律资格”，但医院是否真正纳入本院供应目录，还要看挂网流程、招标程序及医院自身药事管理决策。第二层是药事会审议与准入。即便药品已在省级平台挂网，一家医院通常需要召开药事管理与药物治疗学委员会会议，经过临床科室申请、药学部门评估、委员会投票表决，才能正式批准进入医院处方系统。第三层是临床科室采纳与协议处方。药品进入医院目录后，不意味着每个相关科室医生都会开这张处方。科室主任是否认可其临床价值、是否纳入本科室临床路径或诊疗指南，决定药品在科室内部的“能见度”。第四层是医生个体处方习惯养成。即使科室层面默许，具体到每位医生，处方行为受既往用药经验、学术推广接触深度、患者反馈及同行示范效应影响，从“知道有这个药”到“愿意主动选择”，中间有一段不可忽视的磨合期。第五层是患者实际用药与复购。医生开出处方后，患者是否愿意接受、能否承担自付、是否在用药后持续复诊并继续使用，构成漏斗最后一环。

这五层漏斗并非抽象理论模型，而是每天在医院内部真实发生的决策链条。当瓶颈卡在第一层和第二层时，销售曲线形态表现为典型“阶梯型跳点”。例如，某款创新药在2026年第二季度被某省三甲医院药事会正式批准入院，此前该医院理论上可以采购，但销量为零。药事会一过，药品出现在药房系统中，首单采购可能

直接达数十万元甚至上百万元，单院产出在一个月内实现从0到1跃升。这种跃升不是渐进，而是带有明显台阶特征的跳点。类似地，如果某款药品因纳入基药目录而被基层医院强制要求配备，政策执行节点前后，会看到一大批基层医院在短时间内集中完成准入，形成区域市场阶梯式放量。

但当瓶颈从行政层面下移到第三层和第四层——医生教育与临床路径采纳时，曲线形态从阶梯型转向S型。药品刚进入医院目录初期，医生对其临床证据、不良反应谱、与现有治疗方案对比优势尚不熟悉，处方量增长缓慢。这个阶段可能持续数个季度，甚至一年以上，表现为S型曲线底部平缓期。随着学术推广深入、关键意见领袖示范效应扩散、早期用药患者在真实世界中积累疗效口碑，医生处方意愿开始加速上升，曲线进入快速爬升阶段。当科室核心患者群体基本覆盖、新适应症拓展尚未接力时，单院产出又进入平台期，S型曲线上沿趋于平缓。判断一款创新药在单院层面的爬坡形态，首要任务是识别当前瓶颈究竟位于五层漏斗中的哪一环。行政瓶颈主导的药品，销售曲线更像一串台阶；行为瓶颈主导的药品，曲线更像一条被拉长的S型。现实中，大多数创新药经历“先阶梯、后S型”的混合过程：入院那一刻带来第一个台阶，随后的科室渗透勾勒出S型主体。

■ 高价创新药的爬坡，不是一条直线

即使看清五层漏斗结构，如果认为药品逐层突破就能匀速增长，仍是过于乐观的线性思维。高价创新药在院内市场爬坡，受至少四重外部约束交织作用，产出曲线充满波动与折返，远非一条光滑直线。

第一重约束来自“986”配置政策形式要求。政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%。这一政策本意是推动基本药物优先使用，但对刚纳入基药目录的高价创新药，实际上设置了一个隐性“天花板”。三级医院有最强患者承载能力和学术影响力，但基药占比只需达到60%，意味着即使创新药进入基药目录，医院也没有动力将其配置比例无限推高。价格高昂的生物制剂，每增加一个品种采购金额，都会挤压其他基药品种空间预算，药房管理者和医院管理层决策时非常谨慎。986政策为基药品种提供准入“底数保障”，却不意味着自动获得“无限放量”通行证。

第二重约束来自DRG和DIP控费压力。在按疾病诊断相关分组付费或按病种分值付费体系下，医院为每个病种收治患者所能获得的医保支付额度相对固定。如果创新药价格显著高于传统治疗方案，即使疗效更优，科室使用也会面临直接成本压力。药品费用被纳入病组总费用“打包价”中，多用高价药意味着科室盈余减少，甚至可能出现亏损。虽然部分地区对创新药实行DRG除外支付或成本豁免，但这类政策覆盖范围、执行标准和持续时间在不同地区之间差异显著，高价创新药在

不同城市医院面临支付环境大相径庭。这种支付端约束，直接抑制医生对高价创新药的处方冲动，销售爬坡在达到某个阈值后遭遇明显阻力。

第三重约束是科室预算硬边界。即使DRG/DIP政策有所松动，医院内部科室预算管理体系仍是现实拦路虎。许多医院对药品采购实行预算总额管理，特别是抗肿瘤药物、免疫调节剂等高价专科用药，往往被纳入重点监控目录。科室主任年初制定预算时，需要权衡新引进创新药与既有成熟品种之间的资源配置。如果新药尚未形成强有力临床证据或患者需求，科室通常不会预留大量预算空间，导致创新药入院后初期放量往往受采购额度周期性限制，表现为季度之间波动。

第四重约束是患者支付能力。即使药品已纳入医保，患者实际自付比例仍可能是一笔不小开支。对于需要长期用药的慢性病或自免疾病，患者对持续支付能力的考量显著影响用药依从性。尤其在二三线城市和基层医院，患者对价格敏感度更高，即使医生开具处方，患者也可能因经济压力主动选择替代方案或中断治疗。这种来自需求端约束，使单院产出在触及本地患者支付能力边界后，增长速度迅速放缓。

这四重约束并非孤立存在，而是相互叠加、彼此强化。986政策决定医院是否"必须"配备，DRG/DIP决定科室是否"愿意"使用，科室预算决定药房是否"能够"采购，患者支付能力决定终端是否"持续"消耗。四重约束共同构成一张复杂网，将高价创新药销售曲线从理想直线扭曲成S型与阶梯型交织的混合形态。线性外推的估值方法之所以常常失效，正是因为它忽视了这张网的存在。

CHAPTER 05

真正的拐点，不是入院，而是复购

■ 剪刀差反转，才是瓶颈打通的信号

创新药商业化早期，制药企业通常把"覆盖医院数量"作为最核心跟踪指标。这无可厚非，因为对于刚获批或刚纳入医保的药品，先进医院是一切后续故事的前提。于是，投资者会在财报和调研报告中看到类似数据："截至本季度末，已进入XX家三级医院、YYY家二级医院。"如果这个数字每季度都在快速增长，市场往往给予积极反馈。但单纯追踪覆盖医院数，容易制造虚假安全感。

真正揭示问题的信号，是覆盖医院数与销售收入增速之间的"剪刀差"。商业化初期，覆盖医院数量快速增加，但由于每家医院都处于刚入院、尚未形成稳定处方阶段，整体收入增速可能不匹配。此时，覆盖增速高于收入增速，剪刀差扩大。

这个阶段合理，因为医院准入需要时间，处方习惯养成更需要时间。但如果在一个较长时间窗口内——连续两个或三个季度——覆盖医院数仍在大幅跃升，而收入增速明显掉队，甚至出现环比放缓，剪刀差开始发出警报：瓶颈已后移到处方端。

这意味着药品已成功解决很多"行政性准入"问题，但卡在"行为性采纳"环节。药品名义上已存在于很多医院药房中，但实际上没有被医生真正用起来。患者可能不知道医院有这个药，医生可能因缺乏足够学术推广接触而信心不足，或科室因DRG控费压力刻意限制使用。此时，如果管理层仍把资源集中在"拓展更多医院"，而忽略"激活已有医院"，新增医院覆盖很可能只是重复已有困境——药品进去后，同样停留在形式准入层面，无法产生实际处方转化。

剪刀差反转——收入增速重新追上甚至超过覆盖增速——是判断瓶颈是否打通的最直观信号。当这个信号出现，说明之前入院的大量医院开始从"沉睡账户"转变为"活跃账户"，单院产出进入实质性爬坡期。这个拐点比单纯"进院"更有投资价值，因为它标志着商业化引擎从"靠拓店驱动"切换到"靠同店增长驱动"，后者才是可持续、可预测的现金流来源。

■ 单院持续爬坡，才是真打通

剪刀差反转是宏观预警信号，微观层面，验证科室瓶颈是否真正打通的标准更具体：看单院产出是持续爬坡还是一次性抬升。

一次性抬升在创新药商业化中非常常见。某家医院召开药事会，一次性采购三个月用量；或某个季度因学术会议推动，科室集中采购一批药品。脉冲式销量增长在财务报表上表现为单季度收入跳升，但如果下一季度迅速回落，这种增长本质上只是库存转移，而非终端需求释放。药品从商业公司仓库搬到药房货架，但患者端实际消耗量没有根本性变化。这种"假爬坡"是投资人最容易踩的陷阱之一，因为它在表面制造"放量"假象，但实际未改变科室层面处方行为。

真正的科室瓶颈打通，表现为单院产出在多个连续季度内持续环比增长。这种持续爬坡背后，是药品逐渐嵌入科室临床路径和诊疗常规。例如，某三甲医院皮肤科，一款治疗特应性皮炎生物制剂入院后前两个季度销量平平，但从第三个季度开始，每季度保持15%到20%环比增长。这种增长不是由某一次集中采购驱动，而是因为这一季度科室主任将其纳入中重度患者标准治疗流程，住院医师轮转过程中接受相关用药培训，早期用药患者皮损清除率数据开始在科室内部口口相传，护士站随访流程也逐步建立。所有这些微观层面改变，共同构成单院持续爬坡的底层逻辑。

只有单院产出持续爬坡，而非一次性抬升，才说明科室端瓶颈被真正打通。打通标志不是药品存在于药房目录中，而是存在于医生的认知结构中、科室的临床路径中、患者的随访周期中。这种打通一旦完成，便具有较强锁定效应——改变临床路径和处方习惯成本很高，只要药品疗效和安全性在真实世界中持续验证，科室渗透率就不容易被后来者侵蚀。评估康诺亚、荣昌、先声等企业销售峰值时，必须花大力气跟踪其头部医院单院季度环比数据，而不是仅仅满足于总覆盖医院数的一个大数字。

CHAPTER 06

医院等级不同，爬坡曲线不是同一副面孔

■ 三级、二级、基层，三条不同的路

中国医院体系大体分为三级医院、二级医院和基层医疗机构三个层级。这三个层级在创新药准入效率、科室教育效率和支付约束方面，呈现截然不同特征，导致爬坡曲线显著异质性。

三甲医院是中国医疗体系顶端，拥有最复杂患者结构、最强学术话语权和最繁忙临床workload。对创新药而言，三甲医院准入流程最严格，药事会召开频率较低，委员会成员评估标准最苛刻。从形式准入角度，三甲医院是最难攻克、耗时最长的一环。但一旦突破，三甲医院科室教育效率最高。三甲医院往往是区域医疗中心，科室主任通常是省级甚至国家级学术组织核心成员，处方行为具有很强示范效应和辐射能力。创新药如果在头部三甲医院重点科室站稳脚跟，学术影响力可迅速向周边二级医院和基层机构扩散。三甲医院患者支付能力相对较强，对高价创新药接受度更高。三甲医院虽然准入门槛高、爬坡起步慢，但一旦进入快速爬升阶段，单院产出峰值和爬坡斜率往往是三者中最高的。曲线形态更接近“迟滞的S型”：前段平缓而漫长，中段陡峭而迅猛。

二级医院呈现不同特征。相比三甲医院，二级医院药事会流程相对灵活，医院管理层引入新品种积极性可能更高，因为二级医院面临向上级转诊患者和向下级输出技术双重压力，需要通过引进新药提升诊疗能力吸引力。从形式准入角度，二级医院爬坡曲线前段可能呈现更多阶梯型跳点——药品更容易在短时间内批量进入多家二级医院。但二级医院科室教育效率相对较弱。科室主任学术影响力有限，医生接受新信息渠道不如三甲医院丰富，患者对高价创新药支付能力也不及三甲医院。二级医院入院后S型爬坡阶段往往更为缓慢，单院产出峰值也较低。曲线形态更接近“短台阶+缓S型”：准入跳点密集，但后续爬升乏力。

基层医疗机构最特殊。986政策强制要求下，基层医院对基药目录品种配备具有制度刚性，一旦创新药进入基药目录，基层医院理论上必须纳入采购清单。基层市场准入瓶颈主要集中在第一层，形式准入难度被政策大幅压低。但基层医院在科室教育效率和支付约束方面面临最大挑战。基层医生往往缺乏使用高价生物制剂的培训和经验，患者群体对价格敏感度最高，且许多需要创新药治疗的复杂疾病在基层本就属于转诊范畴。即便药品进入基层医院药房，实际处方量可能非常有限。基层医院爬坡曲线更接近“低平台阶梯型”：准入时有一次性集中配备，但后续很难形成持续S型爬升，单院产出长期停留在较低水平。

如果不区分三个层级，简单把“全国X万家医院”作为同质化整体估算销售峰值，结果会系统性高估基层市场贡献、低估三甲医院爬坡滞后性，最终得到看似宏伟但无法兑现的数字。

■ 科室不同，扩散速度不同

除了医院等级，科室类型是另一个必须分层的维度。不同科室对新药临床证据敏感度、对DRG/DIP预算压力感受、对患者支付能力判断，以及学术扩散速度，都存在显著差异。

肿瘤科是创新药渗透率最高、爬坡速度最快的科室之一。肿瘤患者治疗窗口往往有限，对疗效渴求最为迫切，对临床证据敏感度极高。肿瘤科学术氛围浓厚，医生参与临床试验和学术会议机会多，信息传播速度快。支付端，虽然肿瘤药价格高昂，但患者和家属对肿瘤治疗支付意愿往往强于其他慢性病。肿瘤科DRG/DIP病组费用相对较高，对创新药容纳空间较大。肿瘤创新药科室爬坡曲线通常表现为S型前段较短、中段斜率陡峭，一旦进入快速放量期，科室渗透速度往往超出市场预期。

免疫科和皮肤科呈现不同动态。以特应性皮炎或银屑病为代表的自免疾病，患者群体庞大，但疾病严重程度差异极大，从轻度到重度之间有一个漫长光谱。科室引入新药时，面临复杂患者筛选和分层治疗问题。医生需要判断哪些患者值得使用高价生物制剂，哪些可以继续使用传统疗法。这种分层决策过程，延长S型曲线底部平缓期。自免疾病多为慢性病，患者需要长期用药，对持续支付能力要求更高。自免创新药科室渗透往往更为缓慢、但持续时间更长，S型曲线被横向拉长，峰值到来时间更晚，但稳态期可能更长。

内分泌科和心血管科受DRG/DIP控费强烈影响。这些科室常见病、多发病集中，病组数量多，但单个病组支付额度相对有限。创新药如果价格显著高于传统治疗，很容易触及科室成本红线。在这些科室，创新药爬坡不仅取决于临床证据，还高度依赖医院是否愿意调整DRG分组权重或争取除外支付。政策支持到位地区，

爬坡可能较为顺畅；政策尚未落地地区，爬坡则严重受阻。这种地区异质性，使这些科室创新药销售曲线在不同省份之间高度分化，难以用单一模型预测。

不同科室学术扩散速度也差异明显。肿瘤科学术网络高度集中，关键意见领袖影响力可迅速通过学术会议、指南更新、多中心研究等方式扩散到全国。而在一些相对分散的科室，如风湿免疫科或罕见病科，学术扩散更多依赖区域性专家网络 and 患者组织口碑传播，速度较慢但穿透力更深。这种扩散速度差异，直接决定S型曲线中段斜率——斜率越陡，学术扩散越快；斜率越缓，需要更长时间教育市场和培养处方习惯。

预测模型同时为医院等级和科室类型分别赋形，把三甲医院肿瘤科"迟滞陡峭S型"、二级医院自免科"短台阶缓S型"、基层医院慢病科"低平台阶梯型"等异质性曲线分别估算，再按市场份额加权加总，才能对康诺亚、荣昌、先声等企业单品销售峰值做出稳健可信预测。任何试图用一条统一曲线拟合所有场景的简化模型，都会在现实复杂性面前露出马脚。

CHAPTER 07

爬坡不是起点，而是二次启动

■ 商业化不是一条河流，而是多级瀑布

创新药商业化叙事里，最容易被误解的概念是"爬坡"。大多数人看到漂亮销售曲线图，会本能假设：产品进了医保，医院名单扩张，收入就会像滚雪球一样沿平滑S曲线向上攀爬。真实世界院内商业化，远比这个画面细碎、坎坷，也远没有这么浪漫。

如果把创新药从获批到院内形成稳定销售比作一条河流，这条河不是从山顶发源后直接汇入平原。它要经过峡谷、浅滩、三角洲，最后才能抵达入海口。而"爬坡"这个词汇，通常只被用来描述最后一段平原流速，却忽略了前面所有地形障碍。院内商业链条中，爬坡速率从来不是起点变量，而是二次启动变量。它只有当前面所有前置条件都被满足后，才会真正发挥作用。

把链条拆解得细一些。一款创新药获批上市后，首先要面对国家医保谈判。谈判成功意味着价格被锁定，患者自付比例降低，这是进入医院市场的第一张通行证。但拿到通行证，并不意味着患者能在医院里轻松买到。接下来，还要经历省级招标挂网、医院药事会评审、采购目录列入、科室临床路径纳入、医生处方习惯养成、患者支付闭环打通——每一个环节都是独立门槛，环环相扣。如果前面任何

一道门没有打开，后面所有动作都会失去意义。

这就好比想在高速公路上开车。医保准入是拿到驾照和行驶证，但真正上路，还需要车里有油、收费站放行、路况通畅、目的地有停车位。直接把"拿到驾照"等同于"可以全速行驶"，显然是对现实的过度简化。院内销售模型中，这种过度简化非常普遍。许多模型假设，一旦覆盖医院数达到某个阈值，单院产出就会按固定速率开始爬坡。但现实中，被纳入"覆盖医院名单"的医院里，可能只有一部分真正具备采购资格，具备采购资格的医院里，又只有一部分完成科室教育和临床路径纳入，完成路径纳入的医院里，又只有一部分患者支付闭环真正顺畅。每一层过滤筛掉一部分"纸面潜力"，最后能贡献稳定收入的医院，往往只是冰山一角。

这就是为什么看康诺亚、荣昌、先声等公司单品销售数据时，不能简单把覆盖医院数增长直接翻译成收入增长。覆盖医院数只是必要条件，而非充分条件。真正决定收入曲线的，是被覆盖医院中有多少完成从"可采购"到"实际采购"、从"可处方"到"稳定处方"的转化。这个转化过程不是自动发生的，需要药企医学团队、市场团队、准入团队进行大量地面工作。在这些地面工作完成之前，模型中那条漂亮爬坡曲线，本质上只是一个纸面参数。

■ 爬坡需要三张通行证

爬坡不是起点，真正启动条件是什么？从三个维度理解：医院是否具备真实采购资格、科室教育及路径纳入是否完成、患者支付闭环是否不再成为主要摩擦项。只有三个条件同时满足，单院产出才会开始有效爬坡。

第一个条件是医院真实采购资格。许多创新药纳入医保后，迅速出现在各省挂网目录中，药企也在财报中披露"已进入多少家医院采购目录"。但"进入采购目录"和"医院实际采购"之间，隔着巨大鸿沟。中国公立医院采购体系中，省级挂网只是第一步，医院还需通过自身药事会评审，将药品列入本院采购目录。药事会召开频率、评审标准、议程设置，受医院内部管理节奏严格约束。大型三甲医院可能每季度召开一次药事会，基层医院可能半年甚至一年才召开一次。即使药事会通过，医院还需考虑预算约束、药品品规限制、库存管理等因素，最终决定是否真正下单。药企终端数据中，常见"名义覆盖医院数"远大于"实际采购医院数"。这种水分如果不被挤掉，会直接传导到销售模型预测中，导致未来收入系统性高估。

第二个条件是科室教育及临床路径纳入。即使药品列入医院采购目录，也不意味着医生会主动处方。中国医疗体系中，医生处方行为受多重约束：临床路径、诊疗指南、科室惯例、医保支付政策、甚至医院内部绩效考核指标。如果创新药没有被纳入相关疾病临床路径或诊疗指南，医生开方时面临额外审批流程和风险，

极大抑制处方积极性。药企医学团队需要在准入完成后，投入大量资源进行科室教育、学术交流、临床证据传递，推动药品进入医院临床路径。这个过程往往比准入本身更漫长。学科壁垒较高领域，如肿瘤、自身免疫疾病，路径评审复杂性和学术争议性让周期进一步拉长。康诺亚自免产品、荣昌ADC药物、先声神经领域创新药，都面临类似问题。靶点和机制往往是全新，临床路径纳入需面对现有诊疗体系惯性阻力，不是简单学术推广就能解决。

第三个条件是患者支付闭环顺畅。创新药进医保，意味着医保基金可报销一部分费用，但患者仍需支付自付部分。价格较高创新药，即使自付比例只有20%-30%，绝对金额也可能达数千甚至上万元。患者支付能力有限，或医保报销流程繁琐、周期长，就会在实际处方环节形成摩擦。一些医院对高价药品处方有额度控制，或要求患者先自费垫付再回当地医保报销，增加患者经济负担和时间成本，最终影响处方转化率。药企往往需要配套患者援助项目、商业保险对接、医保报销协助等服务，打通支付闭环“最后一公里”。只有患者觉得“这个药我买得起、买得到、报销不麻烦”，处方行为才会真正稳定。

三个条件同时满足时，单院产出爬坡才会从纸面参数变成现实动能。在此之前，所有销售预测都只是对理想状态的线性外推。评估康诺亚、荣昌、先声等公司销售峰值时，必须保持审慎。它们的创新药或许已进医保，或许已覆盖数百家医院，但真正爬坡才刚刚开始。

CHAPTER 08

科室渗透系数，不是需求比例，而是组织释放效率

■ 同一批入院，不同医院活在不同时间轴

药企财务模型中，科室渗透系数是一个常见参数。通常定义为：在已准入医院中，多大比例目标科室已开始稳定处方。这个定义看起来简单，似乎只是需求比例问题——有多少科室需要这个药，就有多少科室会处方。真实世界逻辑远比定义复杂。科室渗透系数本质上反映的不是需求比例，而是院内组织结构对临床需求的释放效率。同一批准入医院，因药事会节奏、路径评审效率、科室积极性等因素，被分层为快速放量、零星处方、基本未放量三类。这种分层结构决定，不能用一个统一渗透系数概括所有医院，必须理解背后真实机制。

先想象一个场景。假设某款创新药已进入某省三甲医院A和二甲医院B。按简单模型逻辑，两款医院都在覆盖名单上，科室渗透系数应趋同。但实际情况是，医院A

药事会每季度召开，评审效率极高，相关科室主任对创新药接受度强，学术推广顺利，半年内进入多个科室临床路径，处方量稳步增长。医院B药事会半年才开一次，评审流程冗长，科室主任倾向使用熟悉传统药物，学术推广因预算限制无法频繁开展，列入采购目录一年后，仍只在个别科室有零星处方，大部分科室几乎没有动销。两款医院在模型中可能被赋予相同权重，但实际贡献天差地别。

这种分层现象在中国医院体系中非常普遍。药事会节奏是第一大变量。不同医院药事会召开频率差异巨大，有的每季度一次，有的半年甚至一年一次。新纳入医保创新药，如果错过最近一期药事会，就需要等待下一个周期，等待期可能长达数月。在这段时间里，竞品可能抢先完成路径纳入，形成先发优势。路径评审效率是第二大变量。即使药事会通过，药品进入临床路径评审还需经过科室内部学术讨论、伦理审查、用药安全评估等环节。大型教学医院这些环节严谨性和复杂性让周期进一步拉长。基层医院流程简单，但学术资源和评审能力有限，路径纳入质量可能不高。科室积极性是第三大变量。不同科室对创新药接受度差异很大，取决于科室主任学术背景、对新疗法认知程度、既往用药习惯、与药企关系深度。肿瘤科、血液科等前沿学科通常更开放，一些传统科室可能更保守。

看康诺亚、荣昌、先声等公司终端数据，“准入医院数”快速增长时，不能自动假设这些医院都已进入“快速放量”阶段。事实上，大部分可能仍停留在“零星处方”或“基本未放量”阶段。模型科室渗透系数如果假设所有准入医院转化效率一致，就会系统性高估有效放量医院占比，进而高估总收入。

■ 渗透系数背后，三个真实机制

科室渗透系数不是简单需求比例，它映射哪些真实机制？从三个维度理解：重点学科带动效应、路径评审与内部共识形成速度、预算与绩效考核约束。

第一个机制是重点学科带动效应。中国医院体系中，不同学科地位和影响力差异巨大。国家级、省级重点学科通常拥有更多学术资源、更大话语权、更强跨区域影响力。如果创新药率先进入重点学科临床路径，并获得学科带头人背书，辐射效应远超单个科室。重点学科处方习惯往往被下级医院模仿，学科带头人参加的学术会议成为行业风向标，带动效应极大加速科室渗透速度。相反，如果创新药只能进入非重点学科常规路径，影响力局限在小范围内，渗透速度大打折扣。药企推广创新药时，往往把“打造标杆医院、标杆科室”作为核心策略。这个策略本质，是利用重点学科带动效应放大科室渗透系数。

第二个机制是路径评审与内部共识形成速度。创新药进入临床路径，不是一纸批文能完成。需要经过科室内部学术讨论、用药安全评估、成本效益分析，最终形成内部共识。共识形成速度取决于：药品临床证据是否充分、是否有权威指南推

荐、是否有竞品先行纳入、科室内部对创新药态度是否一致。如果创新药有重磅临床试验数据支持，又有国际权威指南推荐，路径评审通常更快，内部共识更容易形成。但如果临床证据存在争议，或与现有标准疗法差异不够显著，路径评审就会陷入拉锯战，内部共识达成遥遥无期。康诺亚、荣昌、先声产品大多处于灰色地带：它们是创新药，但临床证据积累时间不够长，与成熟疗法相比优势还需要更多真实世界数据验证。路径评审过程往往比预期更慢，内部共识形成充满不确定性。

第三个机制是预算与绩效考核约束。中国公立医院体系中，药品采购和处方行为受严格预算约束和绩效考核约束。医院每年有药品采购预算，高价创新药纳入会挤占其他药品预算空间，医院管理层决策时非常谨慎。医保支付改革（如DRG/DIP付费）推进，也让医院对高价药品处方更敏感。如果创新药价格过高，或使用后导致病组医保支付额度超支，医院就有动力限制处方量。科室绩效考核指标直接影响医生处方行为。如果医院将药占比、耗材占比、次均费用等作为硬性考核指标，医生面对高价创新药时就会更犹豫。这些预算和绩效考核约束，本质上是在院内组织结构中设置一道隐形门槛，显著降低科室渗透系数，即使临床需求真实存在。

三个机制共同决定科室渗透系数真实水平。它不是需求比例简单映射，而是院内组织结构、学术生态、管理逻辑综合产物。评估康诺亚、荣昌、先声等公司销售峰值时，如果不能准确理解这些机制，就会对科室渗透系数做出错误估计，最终导致销售峰值系统性误判。

CHAPTER 09

政策传导不是打折，而是两段衰减

■ 986数的是品种，不是处方

国家医保创新药商业化叙事中，986政策是一个经常被提及的利好因素。市场普遍认为，纳入基药目录意味着医院必须配备，从而带来覆盖医院数快速扩张和销量显著提升。这种理解过于简化政策传导复杂性。986约束的是医院配备品种数量占比，而非实际采购金额或处方量。对高价创新药，这种约束可能只带来形式配置，而非实质采购。政策真正集中点，在"目录列入"和"院端形式配置"两个层面，而非"临床处方"和"稳定复购"层面。

拆开来看。基药目录核心逻辑是保障基本医疗需求，目录内药品以价格低廉、临床必需、供应稳定为遴选标准。创新药，尤其是近年通过医保谈判进入市场的生物药、小分子靶向药，往往价格较高，治疗领域较窄，患者群体相对有限。高价创新药纳入基药目录后，医院确实需要形式上完成配备品种数要求，但配备不等于采购，采购不等于处方，处方不等于稳定复购。医院可通过小批量采购、象征性入库满足形式配置要求，实际临床中仍优先使用价格更低、医生更熟悉的传统药物。这种"形式配置"在高价创新药领域非常普遍。

更重要的是，986政策对不同类型创新药影响差异巨大。对于价格适中、临床必需性强、替代疗法有限品种，986约束确实能推动医院从形式配置走向实质采购。但对于价格高昂、临床证据尚不充分、或已有成熟替代疗法品种，986推动作用可能仅限于"目录列入"和"院端形式配置"两个层面。政策形成传导漏斗：从目录列入到医院药事会评审，从药事会到采购目录列入，从采购列入到实际处方，从处方到稳定复购——每一层衰减一部分政策效力。用单一折扣率概括这种衰减，就会忽略不同品种在政策传导中的弹性差异，对政策真实效果做出错误判断。

康诺亚、荣昌、先声等公司核心单品大多属于高价创新药。康诺亚自免生物制剂、荣昌ADC药物、先声神经领域创新药，价格都远高于传统基药。986政策下处境：会被医院形式上配备，但实际采购和处方中面临更大阻力。医院管理层平衡基药配备占比和药品预算控制时，倾向用低价基药填充数量指标，高价创新药采购需要更多理由和审批流程。政策对这些品种传导衰减因子，实际上比市场普遍认为更大。

■ 覆盖阶段不同，政策弹性不同

政策传导衰减另一关键维度，是品种自身覆盖数水平。覆盖数较低品种，政策改善更多体现在医院覆盖扩张；覆盖已广泛品种，政策边际帮助迅速下降，瓶颈从准入转向单院产出。

这个逻辑很好理解。假设一款创新药目前只覆盖10%目标医院。986政策推动医院基药配备要求，可直接帮助它进入更多此前未覆盖医院。每新增一家医院，都是对收入曲线实质性贡献。此时政策边际效用显著，覆盖医院数增速可作为收入增长重要驱动力。但如果一款创新药已覆盖70%甚至80%目标医院，986政策帮助大打折扣。已覆盖医院中，大部分已完成形式准入，真正瓶颈在于多少医院完成科室渗透、路径纳入、处方习惯养成。再增加10%覆盖医院数，对总收入贡献远不如提升已有医院单院产出来得重要。

这就是为什么不能对所有创新药使用统一政策传导模型。康诺亚、荣昌、先声不同单品，处于不同覆盖阶段。有些品种近两年刚获批并纳入医保，覆盖数还在快

速提升期，986政策帮助主要体现在覆盖扩张。有些品种上市较早、覆盖已相对广泛，增长瓶颈已转向单院产出爬坡。对这两类品种，政策弹性完全不同。模型用统一折扣率处理986政策作用，就会对前一类品种低估政策覆盖扩张效应，对后一类品种高估政策单院产出提升效应。

更微妙的是，覆盖数较低时，新增医院往往更容易实现“快速放量”——因为这些医院往往是政策敏感度较高、流程相对简化、竞品较少的基层或新兴医院。覆盖数较高时，剩下未覆盖医院往往是“硬骨头”——药事会节奏慢、科室保守、预算紧张、竞品已根深蒂固。覆盖后期边际扩张成本更高，转化效率更低。如果不能区分这些阶段性差异，就会对政策真实贡献做出系统性误判。

评估康诺亚、荣昌、先声等公司销售峰值时，必须把政策传导衰减因子拆解为两段效率：第一段“目录列入到形式准入完成”效率，第二段“形式准入到实质采购与稳定处方”效率。不同品种在这两段效率上表现差异巨大，不能一概而论。只有如此，才能准确翻译“纳入基药”对销售峰期的真实含义。

CHAPTER 10

串行门槛不可跳过，并行准备可以加速

■ 串行环节，是硬性时间门槛

分析创新药院内商业化时，市场最常用模型之一是S曲线——假设销售从起步到成熟经历平滑、先慢后快再慢过程。真实世界院内漏斗，不遵循平滑S曲线。更像多级阶梯，每一级有明确高度，必须一级一级爬上去，不能沿斜坡匀速前进。阶梯式结构本质，是院内漏斗中存在大量“串行门槛”。这些门槛是硬性时间约束，无法通过增加资源投入并行跨越，决定销售曲线真实形状是阶段性、非平滑。

串行环节逐一梳理。第一个环节是药品目录纳入。创新药获批上市后，首先要被纳入国家医保目录，通常需等待一年一度医保谈判窗口。错过当年谈判，就需再等一年。第二个环节是医院药事会评审。药品纳入医保后，还需在省级层面完成招标挂网，然后进入各家医院药事会评审。药事会召开频率不是药企可以控制的，取决于医院内部管理节奏。如果药品年初纳入医保，但目标医院药事会安排在下半年召开，就必须等待这半年空窗期。第三个环节是采购目录列入。药事会评审通过后，药品才能进入医院采购目录，医院采购部门才会开始下单。这个环节通常不会太长，但如果遇到医院预算调整、采购系统升级、供应商变更等特殊情况，也可能延迟。第四个环节是实际处方。采购目录列入后，医生还需经过科室

教育、临床路径培训、用药习惯养成等过程，才会开始稳定处方。这个环节时长取决于医生接受度、科室学术氛围、竞品先发优势等多种因素。第五个环节是稳定复购。初次处方后，患者需感受疗效，医生需积累用药经验，医院需确认药品供应稳定性和成本效益，处方行为才会从试探性变为稳定复购。这个环节建立往往需要数个季度甚至更长时间。

这些环节之间严格串行。不能在药品还没纳入医保时就去推动医院药事会评审；不能在药事会还没通过时就要求医生处方；不能在医生还没初次处方时就期待稳定复购。每一个环节必须等待前一个环节完成后才能启动，串行结构构成院内漏斗硬性时间门槛。无论投入多少市场费用、组织多少学术活动、动员多少销售力量，都无法跳过这些门槛。销售曲线真实形状不是平滑S曲线，而是阶梯式：每一个串行门槛被跨越后，曲线出现一个台阶式跃升；两个门槛之间，曲线相对平坦，甚至可能因为外部因素（竞品进入、政策调整、医院管理层变动）出现波动。

康诺亚、荣昌、先声等创新药，在各自院内漏斗中都面临这些串行门槛约束。如果市场对它们销售预期假设平滑S曲线，忽略阶梯式结构，就会对销售节奏产生系统性误判。例如，医保纳入后第一个季度，市场可能预期销售已开始快速爬坡，但实际上这个季度可能还在等待药事会召开；药事会通过后第二个季度，市场可能预期销售已放量，但实际上这个季度可能还在进行科室教育和路径沟通。只有理解串行门槛存在，才能对销售曲线真实节奏做出更准确预测。

■ 并行准备，缩短门槛之间的等待

串行门槛无法跳过，但院内漏斗中并非所有环节都是串行。"放量准备"阶段，存在大量可以并行推进工作，这些并行工作效率，直接决定销售周期能否被有效缩短。只关注串行门槛而忽略并行准备，就会对销售启动速度过于悲观；高估并行准备效率，就会过于乐观。

"放量准备阶段"，指从药品获批到开始稳定处方之前的整个窗口期。虽然串行门槛必须按部就班跨越，但围绕这些门槛的准备工作可以并行开展。具体包括：科室教育、标杆医生建设、重点学科路径沟通、患者支付支持。

科室教育可在药品还没正式进入医院采购目录之前就开始。药企医学团队提前与目标科室主任、骨干医生建立联系，通过学术会议、病例讨论、临床研究合作等方式，传递药品临床证据和使用经验。前期教育虽不能直接带来处方，但可在药品正式进入医院后，加速医生接受度和处方积极性。标杆医生建设是科室教育高级形式。通过在重点医院、重点科室打造一批早期使用者，形成示范效应，可极大缩短后续医院科室教育周期。标杆医生病例报告、学术演讲、临床经验分享，是推动内部共识形成的重要催化剂。重点学科路径沟通需要与学科带头人、学术

组织、指南制定机构保持密切互动。如果在药品获批后、医保纳入前，就开始推动药品进入相关学科诊疗指南或专家共识，后续医院路径评审中就会占据更有利地位。患者支付支持需要在医保准入前就开始规划，包括与商业保险公司合作、患者援助项目设计、医保报销流程优化等。支付支持措施落地，可在药品正式进入医院后，迅速打通患者自付瓶颈，减少处方摩擦。

这些并行工作价值在于，不能改变串行门槛硬性时间约束，但可以缩短门槛之间过渡时间。如果科室教育在药事会召开前已完成，药品在采购目录列入后，就可迅速进入处方阶段，不需要再等待数月完成科室教育。如果标杆医生建设在医保谈判前已启动，一旦谈判成功，标杆医生就可迅速成为推广支点，带动周边医院跟进。如果患者支付支持在药品上市前已搭建完成，药品进入医院后，患者就可立即享受顺畅支付体验，减少处方流失。

康诺亚、荣昌、先声等公司在并行准备方面能力差异，直接影响各自单品销售启动速度。有些公司准入很强，但医学团队建设滞后，导致药品进入医院后迟迟无法启动处方。有些公司标杆医生建设投入不足，科室渗透速度远低于预期。有些公司患者支付支持缺乏系统规划，患者在处方环节因支付问题流失。这些差异最终体现在销售曲线形状上，成为区分不同公司商业化能力的关键变量。

CHAPTER 11

参数误差不是平移，而是放大为分批放量

■ 误差先改变分层，再扭曲总量

创新药销售预测模型中，参数误差无处不在。但误差影响方式，往往不是简单线性平移，而是在链条中逐步放大，最终表现为“分批放量”非均匀节奏，而非整体曲线平滑前移或后移。理解这种放大机制，对纠正市场节奏理解至关重要。

从简单假设开始。假设模型对科室渗透系数估计为50%，即认为所有准入医院中，一半目标科室已开始稳定处方。如果实际科室渗透系数只有30%，直观上似乎高估了67%。但真实误差传导远比这个复杂。因为参数误差首先改变的不是总量，而是医院分层结构。

当科室渗透系数被高估时，模型假设更多医院已进入“稳定产出”阶段，更少医院停留在“零星处方”或“基本未放量”阶段。这意味着，模型对未来收入增量预测，过多依赖“稳定产出医院”单院产出增长，过少依赖“新增准入医院”覆盖扩张。但现实中，由于科室渗透系数实际更低，真正处于“稳定产出”阶段医院占比更少，处于“

零星处方"或"基本未放量"阶段医院占比更多。导致两个后果：第一，短期内实际收入低于模型预测，因为"稳定产出医院"数量少于预期；第二，中长期内实际收入增长节奏扭曲，因为模型假设已完成的科室渗透实际上还需要更长时间实现，覆盖扩张带来的增量又因医院分层结构被错误估计而被低估或高估。

分层结构改变，还会进一步影响其他参数估计。如果模型高估"稳定产出医院"占比，就会低估这些医院从"零星处方"到"稳定产出"转化周期。导致对后续季度收入增量预测过于乐观。同时，模型还会低估药企在科室教育和路径沟通方面需要投入资源，因为它假设这些工作已在前期完成。实际投入不足时，科室渗透进度进一步放缓，形成恶性循环。康诺亚、荣昌、先声等公司在不同阶段销售数据中，都可能出现参数误差放大现象。例如，某季度覆盖医院数增长20%，但收入只增长5%，很可能因为新增医院大部分停留在"零星处方"阶段，而模型假设它们已进入"稳定产出"阶段。如果不能识别这种分层结构变化，就会对下一季度销售预期做出错误调整。

■ 渗透系数高估，是把脉冲 smoothed 成曲线

参数误差中，科室渗透系数高估最常见、影响最深远。它不仅改变医院分层结构，还直接导致对稳定产出医院数高估、收入曲线错误平滑和前置。

当科室渗透系数被高估时，模型假设在已覆盖医院中，更大比例目标科室已开始稳定处方。这意味着，模型对"有效放量医院数"估计高于实际水平。有效放量医院数是驱动收入增长核心变量之一，它的高估直接传导到收入预测。更严重的是，高估会导致收入曲线被错误平滑。真实院内漏斗中，收入增长是阶梯式，因为不同医院准入时间、药事会节奏、科室渗透速度各不相同，放量时间点分散。这种分散性使总收入曲线呈现"分批放量"特征：某月或某季度，几家医院集中完成科室渗透，带来收入脉冲式上升；接下来几个月，收入又回归相对平稳。如果模型假设科室渗透系数统一、较高，就会把分散脉冲式放量平滑为连续曲线，掩盖真实销售节奏。

此外，科室渗透系数高估还会导致收入曲线被错误前置。模型假设科室渗透较短时间完成，意味着把未来收入增量提前到近期预测。销售曲线看起来比实际更陡峭，峰值出现时间比实际更早。康诺亚、荣昌、先声等公司，如果市场基于错误前置收入曲线给出过高估值，真实销售节奏被揭示时，就会面临巨大估值回调压力。生物医药板块中屡见不鲜：一款创新药纳入医保后前几个季度，覆盖医院数快速增长，市场基于乐观假设给出高估值；随时间推移，真实销售数据陆续披露，显示科室渗透滞后和单院产出爬坡缓慢，估值迅速回落。

评估这些公司销售峰值时，必须对科室渗透系数保持高度敏感。与其假设统一、较高渗透系数，不如深入分析每家医院真实状态，识别"快速放量"、"零星处方"、"基本未放量"三类医院实际占比，根据分层结构重新校准收入曲线。只有这样，才能避免参数误差在链条中被放大，扭曲对销售节奏的理解。

CHAPTER 12

剪刀差是模型失效的最早警报

■ 覆盖大增，收入不增，参数一定错

创新药商业化跟踪中，最直观预警信号是"覆盖医院数与收入增速的剪刀差"。当覆盖医院数大幅增长，而收入增速未同步改善时，说明模型中间参数被错设，最常见原因是科室渗透系数被高估，新增医院大部分停留在"已列入目录但处方极少"阶段。

用具体例子说明。假设某创新药第一季度覆盖100家医院，单季度收入1000万元；第二季度覆盖医院数增加到150家，增长50%，但单季度收入只增加到1200万元，增长20%。明显剪刀差：覆盖增长50%，收入增长20%。如果只看覆盖医院数，可能认为商业化进展顺利；但看收入增速，就会发现问题。剪刀差本质是什么？新增50家医院对收入贡献非常有限。这50家医院中，可能大部分只完成形式准入（列入采购目录），但还没开始实质性处方；或虽有零星处方，但处方量极低，远未达稳定产出水平。覆盖医院数增长只是"名单扩张"，不是"实际销售扩张"。

剪刀差出现，是模型失效最直接信号。正常商业化逻辑中，覆盖医院数和收入增速应呈现一定正相关性。覆盖增长50%，收入只增长20%，要么新医院单院产出远低于已有医院，要么新增医院中有大量"僵尸医院"（名义覆盖但实际未处方）。无论哪种情况，都说明模型对"有效放量医院占比"或"科室渗透系数"假设过于乐观。如果模型假设新增医院覆盖后第二个季度就能达到平均单院产出50%，实际数据就会严重低于预期。这种错设如果不能及时识别，就会对未来销售预测产生系统性偏差。

康诺亚、荣昌、先声等公司，需密切跟踪季度披露数据，特别是覆盖医院数与收入增速之间匹配度。如果连续几个季度出现覆盖大增而收入增速明显滞后，这是强烈警示信号，提示需重新审视模型中间参数，尤其是科室渗透系数和单院产出爬坡速率。这可能意味着，市场此前对这些公司销售峰值估计过于乐观，需要向

下修正。

■ 处方监测，比名单更诚实

覆盖医院数与收入增速剪刀差是预警信号，如何更精确捕捉科室渗透真实状态？处方监测比覆盖名单更敏感。药企终端数据中，覆盖名单是最粗略指标，只能告诉我们“药品在哪些医院采购目录上”，无法告诉我们“这些医院实际上有没有处方”。回答后一个问题，需要更细粒度数据层次。

第一个层次是企业终端覆盖数据。药企通过自己的销售团队或经销商收集，通常包括“已进入多少家医院采购目录”。好处是及时、可得，坏处是粗糙。只能反映“名单扩张”，不能反映“实际动销”。如果一款药在1000家医院采购目录上，但只在100家医院有实际处方，企业终端覆盖数据给出1000家数字，掩盖900家“僵尸医院”存在。

第二个层次是医院采购平台数据。通过各省药品集中采购平台或医院采购系统获取，反映医院是否实际下单采购、采购量多少。比覆盖名单更接近真实，至少能区分“形式配置”和“实质采购”。但盲点仍在：采购不等于处方。医院可能采购一批药品入库，但医生处方积极性不高，药品长时间积压在药房，没真正到达患者手中。

第三个层次是重点城市处方监测数据。通过第三方数据公司（如IQVIA、米内网等）对重点城市医院处方监测，获取药品实际处方量和患者数。最接近“科室渗透是否真实发生”答案，直接反映医生是否在临床上使用这个药品。但处方监测数据也有局限：覆盖范围通常只包括重点城市大型医院，对基层医院、非重点城市覆盖不足；数据获取存在滞后性，通常需一到两个季度才能看到完整趋势；数据精度受样本选择和统计方法影响，可能存在偏差。

尽管如此，处方监测数据仍是三个层次中最敏感、最能反映真实渗透指标。如果处方监测数据显示，某创新药在重点城市处方量稳步增长，即使企业终端覆盖数据增长较慢，也可判断科室渗透在真实发生。反之，如果处方监测数据显示处方量停滞或下降，即使企业终端覆盖数据仍在增长，也说明科室渗透遇到瓶颈。

康诺亚、荣昌、先声等公司，需要建立多层数据交叉验证框架。不能仅仅依赖企业披露的覆盖医院数，而要通过医院采购平台数据和重点城市处方监测数据交叉验证。三个层次数据趋势一致，说明商业化进展扎实；出现剪刀差，就需要深入分析背后原因，及时调整对销售峰值预期。覆盖医院数只是商业化起点，处方监测数据才是商业化终点。真正理解这一点，才能在创新药投资研究中，避免被“名单扩张”表象迷惑，看到“真实渗透”本质。

单院层面是"S型+阶梯型"混合形态，跨院层面是"覆盖与收入剪刀差"拐点，分层层面是"医院等级×科室类型"异质性赋形。把"纳入基药"这个模糊的政策利好，翻译成可量化、可跟踪、可验证的"可院内用药医院数的季度增速"，以及每一层级医院背后真实的科室渗透率变化。如此，才能避免对创新药销售峰值做出线性外推的幻觉，在药企商业化的迷宫中找到那条真正通往现金流的窄门。
